

TABLE DES MATIERES

SITUATION INITIALE ET ASPECTS FORMELS.....	3
DÉROULEMENT DU MANDAT D'EXPERTISE	3
MOTIF ET CIRCONSTANCES DE L'EXPERTISE	3
APERÇU DES SOURCES UTILISÉES	3
SYNTHÈSE DU DOSSIER	3
DOCUMENTS AU DOSSIER (RAPPORTS MÉDICAUX (RM), DOC. ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES)	3
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS OBTENUS EN COURS D'EXPERTISE.....	4
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE	6
QUESTIONNAIRE DE L'ASSURANCE	10
1. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ?	10
2. QUELLES SONT LES PLAINTES ACTUELLES ?	11
3. QUELLES CONSTATATIONS PSYCHOPATHOLOGIQUES, Y COMPRIS LES RÉSULTATS D'ÉVENTUELS EXAMENS COMPLÉMENTAIRES (LABORATOIRE/MÉDICAMENTS), POUVEZ-VOUS FOURNIR ?	12
4. QUELS SONT LES MÉDICAMENTS PRIS / LES THÉRAPIES EFFECTUÉES (DOSAGE, QUANTITÉ, FRÉQUENCE) ?	13
5. QUEL(S) EST / SONT LE/S DIAGNOSTIC(S) AYANT UNE INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL (VEUILLEZ INDIQUER LE CODE CIM) ?	13
6. QUEL(S) EST / SONT LE/S DIAGNOSTIC(S) N'AYANT PAS D'INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL (VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE CIM)? ...	13
7. QUEL EST LE TAUX D'ACTIVITÉ ESTIMÉ (EN POURCENTAGE) DANS L'EMPLOI ACTUEL, Y COMPRIS LES RAISONS ET LE PRONOSTIC ?	14
8. QUEL EST LE TAUX D'ACTIVITÉ ESTIMÉ (EN POURCENTAGE) DANS UN EMPLOI ADAPTÉ, Y COMPRIS LES RAISONS ET LE PRONOSTIC ?	14
9. EST-CE QU'UNE ADAPTATION DU TRAITEMENT/DE LA THÉRAPIE, POURRAIT AVOIR UN EFFET BÉNÉFIQUE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL (PARTIELLE). SI OUI, LE(S)QUEL(S), POUR QUELLES RAISONS ET QUEL SERAIT LE PRONOSTIC ?	14
10. REMARQUES.....	15
DOCUMENTS ANNEXES.....	16
EXAMENS EFFECTUÉS LORS DE L'EXPERTISE	16

SITUATION INITIALE ET ASPECTS FORMELS

Déroulement du mandat d'expertise

Vous nous avez mandatés le 09.01.2026.

Le rapport d'expertise vous a été envoyé le 25.02.2026, date officielle du présent document.

L'expertisé s'est présenté au bureau d'expertises médicales le 10.02.2026.

L'examen psychiatrique a duré : 1h30.

Motif et circonstances de l'expertise

Contexte du mandat et faits médicaux

En tant qu'assureur, vous souhaitez évaluer l'incapacité de travail de Monsieur Thomas Aubert. Dans ce cadre, vous avez besoin d'informations détaillées sur son état de santé et l'influence de celui-ci sur sa capacité de travail et sur ses possibilités d'intégration professionnelle.

Pour ce faire, il est nécessaire d'évaluer les diagnostics et les limitations fonctionnelles qui en découlent afin d'établir l'exigibilité dans l'ancien poste de travail ou dans un éventuel poste adapté.

Questions posées

Cf. annexe conclusions de chaque spécialiste.

Remarque

Les termes « assuré », « expertisé », « lui », etc. s'entendent au masculin comme au féminin.

Profil d'exigences pour l'activité actuelle

L'assuré travaille en tant que responsable marketing à taux d'activité de 100%.

Aperçu des sources utilisées

Notre rapport se base sur le dossier remis par vos soins, les examens cliniques, paracliniques radiologiques, la confrontation radio-clinique et notre synthèse consensuelle.

SYNTHÈSE DU DOSSIER

Documents au dossier (Rapports médicaux (RM), doc. administratifs et juridiques)

15.09.2025 Certificat médical - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 4)

ITT à 100% du 15.09.2025 au 06.10.2025 pour cause de maladie.

06.10.2025 RM psychologique - M. Jonathan Matile, Psychologue FSP, Psychoénergie, Pully (p 21-22)

Évaluation psychologique de M. Thomas Aubert confirmant un épisode dépressif modéré à sévère et un burnout professionnel. Scores élevés au Maslach Burnout Inventory et à l'Inventaire de Dépression de Beck. Recommandation d'arrêt de travail et suivi psychologique pour stabilisation de l'humeur et restauration du sommeil. Conseils pour le rétablissement : contacts sociaux, activité physique, structuration des journées.

06.10.2025 Certificat médical - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 1)

ITT à 100% du 06.10.2025 au 27.10.2025 pour cause de maladie.

06.10.2025 Rapport ECG (p 10)

Résultat du diagnostic : Rythme sinusal ECG normal.

27.10.2025 Certificat médical - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 20)

ITT à 100% du 27.10.2025 au 17.11.2025 pour cause de maladie.

17.11.2025 Certificat médical - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 2)

ITT à 100% du 17.11.2025 au 08.12.2025 pour cause de maladie.

17.11.2025 Attestation médicale - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 3)

Le Dr Sampieru Felli atteste que Thomas Aubert peut voyager en France du 19 au 22 novembre 2025 sans compromettre son traitement médical, malgré son arrêt de travail.

08.12.2025 Attestation médicale - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 18)

Monsieur Thomas Aubert est autorisé à se rendre en France du 19.12.2025 au 04.01.2026 pendant son arrêt de travail, sans compromettre son traitement médical.

08.12.2025 Certificat médical - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 17)

ITT à 100% du 08.12.2025 au 06.01.2026 pour cause de maladie.

09.12.2025 Premier certificat médical - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 5-9)

Fatigue psychologique persistante depuis juillet 2024, aggravée en décembre 2024. Symptômes incluent humeur triste, troubles du sommeil, épisodes de sidération, surcharge cognitive et émotionnelle, difficultés de concentration, irritabilité, et consommation excessive d'alcool. Diagnostic de burnout et suspicion de dépression. Traitement par psychothérapie et médication (Sertraline). Trouble anxio-dépressif impactant l'incapacité de travail. Difficultés de concentration et irritabilité affectant l'activité professionnelle. Le patient attribue une grande part de son état actuel à son environnement professionnel. Traitement actuel : Sertraline 100 mg/jour et psychothérapie. ECG du 06.10.2025 normal. Consultation spécialisée en psychiatrie prévue fin janvier 2026. Incapacité de travail totale depuis le 15.09.2025.

06.01.2026 Certificat médical - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 19)

ITT à 100% du 06.01.2026 au 29.01.2026 pour cause de maladie.

Renseignements et documents obtenus en cours d'expertise**Liste des médicaments :**

- Sertraline 150mg
- Melioran

Liste des médecins :

- Dr Sampieru Felli, Médecin généraliste, Maison de Santé Pully, à Pully
- M. Jonathan Matile, Psychologue, Pully
- Dr William Caredda, Psychiatre, Lausanne

CV**15.09.2025 Certificat médical Dr Sampieru Felli, médecin généraliste, Pully (p 3)**

Certificat médical indiquant que l'assuré est en incapacité de travail pour raisons médicales du 15.09.2025 au 06.10.2025 à 100%.

06.10.2025 Certificat médical Dr Sampieru Felli, médecin généraliste, Pully (p 4)

Certificat médical indiquant que l'assuré est en incapacité de travail à 100% pour raisons médicales du 06.10.2025 au 27.10.2025. Réévaluation nécessaire.

06.10.2025 RM M. Jonathan Matile, psychologue FSP, Pully (p 1-2)

Évaluation psychologique de l'assuré, confirmant un trouble dépressif moyen à sévère et un burnout significatif. Scores élevés à l'Inventaire de Dépression de Beck et au Maslach Burnout Inventory. Recommandation d'arrêt de travail et suivi psychologique pour stabilisation de l'humeur et gestion du stress. Conseils pour le rétablissement : contacts sociaux, activité physique, structuration des journées.

27.10.2025 Certificat médical Dr Sampieru Felli, médecin généraliste, Pully (p 5)

Certificat médical indiquant que l'assuré est en incapacité de travail pour raisons médicales du 27.10.2025 au 17.11.2025, à 100%.

17.11.2025 Certificat médical Dr Sampieru Felli, médecin généraliste, Pully (p 6)

Certificat médical du Dr Sampieru Felli confirmant l'incapacité de travail de l'assuré du 17.11.2025 au 08.12.2025 à 100% pour raisons médicales. Réévaluation nécessaire.

17.11.2025 Attestation médicale - Dr Sampieru Felli, Maison de Santé Pully (p 7)

Le Dr Sampieru Felli atteste que Thomas Aubert peut voyager en France du 19 au 22 novembre 2025 sans compromettre son traitement médical, malgré son arrêt de travail.

08.12.2025 Certificat médical Dr Sampieru Felli, médecin généraliste, Pully (p 8)

Certificat médical indiquant que l'assuré est en incapacité de travail à 100% du 08.12.2025 au 06.01.2026 pour raisons médicales. Réévaluation nécessaire.

08.12.2025 Certificat médical Dr Sampieru Felli, médecin généraliste, Pully (p 9)

L'assuré est autorisé à se rendre en France du 19.12.2025 au 04.01.2026 pendant son arrêt de travail, sans compromettre son traitement médical.

06.01.2026 Certificat médical Dr Sampieru Felli, médecin généraliste, Pully (p 10)

Certificat médical confirmant l'incapacité de travail l'assuré du 06.01.2026 au 29.01.2026 à 100% pour raisons médicales. Aucune réévaluation nécessaire.

29.01.2026 Certificat médical Dr William Caredda, psychiatre, Lausanne (p 11)

Je certifie que l'état de santé de l'assuré est incompatible avec le travail, incapacité 100% maladie jusqu'au 28/02/2026. Fait le 29/01/2026.

Contrôles et relecture finale



Joëlle von Bueren

Directrice associée BEM-Riviera

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

Anamnèse (données subjectives de l'expertisée)

Indications fournies spontanément par l'expertisée

L'assuré se présente décrit une rupture progressive de ses capacités d'adaptation après plusieurs années d'investissement professionnel très intense dans une fonction à haute responsabilité au sein d'une fédération sportive internationale. Il rapporte une surcharge chronique, un rythme de déplacements élevé et des journées prolongées sans récupération, qu'il identifie comme le facteur principal de sa décompensation.

Troubles actuels, apparition et évolution des limitations, réactions de l'entourage

L'assuré décrit avoir longtemps fonctionné au-delà de ses limites sans en percevoir les effets, jusqu'à l'apparition de manifestations qu'il qualifie lui-même de "*disproportionnées*" par rapport aux situations vécues. Il indique avoir longtemps considéré ce fonctionnement comme normal pour lui et ne pas avoir perçu immédiatement l'installation des difficultés, habitué à un niveau élevé de performance et de résistance au stress. Ce n'est que rétrospectivement qu'il identifie une période de fatigue psychique persistante dès l'été 2024, période d'intense charge lorsqu'il travaillait aux JO de Paris, avec une aggravation nette en décembre 2024 dans un contexte de tensions professionnelles, de sentiment de manque de soutien hiérarchique et de remise en question de son travail.

Il décrit alors l'apparition progressive d'une fatigue importante, d'une tension interne permanente, d'une irritabilité inhabituelle et d'une anxiété de fond avec ruminations centrées sur le travail. Le sommeil s'est progressivement désorganisé avec un endormissement tardif et des réveils nocturnes en lien avec des préoccupations professionnelles. A cela s'est associé une diminution de l'appétit avec une perte pondérale. L'assuré évoque un épisode de sidération lors d'un déplacement à l'étranger au cours duquel il s'est retrouvé immobilisé pendant plusieurs heures, incapable d'initier des actions simples. Il décrit à cette période une majoration de la fatigue, associée à des états d'envahissement anxieux, des comportements d'évitement, des troubles attentionnels et des idées de mort : il mentionne par ailleurs qu'à l'occasion d'un accident de vélo, sans conséquence grave, lui est venue de manière fugace la pensée qu'il aurait pu "*ne pas éviter l'impact*". En fin août 2025, il rapporte avoir été orienté vers un suivi psychologique, au retour d'un championnat au Canada, marqué par plusieurs interurrences qui l'ont fortement impacté.

Malgré ces manifestations, il a poursuivi son activité professionnelle, en se rendant à des événements à l'étranger jusqu'à un état d'épuisement avancé, où il dit avoir consommé de l'alcool de manière inhabituelle, ce qu'il indique comme étant "*la goutte d'eau*". Le dossier médical confirme cette évolution avec une incapacité de travail totale ininterrompue depuis le 15 septembre 2025. L'évaluation psychologique met en évidence un état dépressif d'intensité moyenne à sévère dans un contexte de burnout professionnel, avec des scores pathologiques aux échelles de dépression et d'épuisement. Le médecin traitant décrit une surcharge cognitive et émotionnelle, des troubles de la concentration, une irritabilité et une consommation d'alcool augmentée. Un traitement par Sertraline a été introduit et secondairement majoré lors du suivi psychiatrique. L'assuré décrit depuis, l'introduction de l'antidépresseur, une stabilisation de son état, sans aggravation, mais sans récupération franche de son niveau de fonctionnement antérieur.

Entretien approfondi

Biographie rapportée par l'expertisée : Monsieur a grandi en région Parisienne. Il rapporte une enfance "*heureuse*", sans événement traumatique majeur ni maltraitance. Son père, ancien chef d'entreprise, est décédé en 2015 à 78 ans. Sa mère, ancienne représentante commerciale, est

âgée de 70 ans. Ses parents se sont séparés quand il avait 10 ans. Il se décrit comme un enfant plutôt indépendant, peu attiré par une vie sociale intense, très investi dans son activité sportive qui a constitué le fil conducteur de son parcours. Les relations familiales actuelles sont décrites comme bonnes, en particulier avec sa mère.

Description de son quotidien avant les événements marquants : Avant le début des troubles, le quotidien de l'assuré était organisé selon une alternance entre des périodes de travail très intensives et des périodes à domicile plus calmes. Lors des événements internationaux, qui s'étendaient sur une douzaine de jours, à plusieurs reprises dans l'année et dans différents pays, il travaillait selon des amplitudes horaires très larges, devant être présent environ une heure avant l'arrivée des athlètes et quittant les lieux environ une heure après leur départ. Les horaires de sommeil et les repas étaient entièrement déterminés par le calendrier des compétitions, sans rythme régulier. Lorsqu'il était à la maison, il se levait habituellement entre 6h et 7h, prenait un café sans petit déjeuner et consacrait la matinée à des activités domestiques, notamment la cuisine qu'il décrit comme une "*passion*". Il commençait souvent à préparer le repas du soir en milieu d'après-midi pour son épouse. Ces périodes lui permettaient également de pratiquer régulièrement du sport, en particulier le vélo et le tir à l'arc. Le coucher était en règle générale autour de 23h et le sommeil était alors décrit comme de bonne qualité.

Aspects sociaux : L'assuré décrit disposer d'un cercle amical restreint mais stable et fiable. Il souligne que ce réseau social constitue un soutien important dans la période actuelle et qu'il est même en contact avec certains de ses amis plus fréquemment qu'auparavant. Il n'a jamais eu un mode de vie marqué par de nombreuses sorties ni par des activités sociales étendues. Il ne rapporte pas de fréquentation régulière de bars, d'événements culturels ou de manifestations de grande ampleur.

Événements marquants : Interrogé sur les éléments susceptibles d'avoir contribué à l'apparition de la symptomatologie actuelle, l'assuré identifie en premier lieu la période des Jeux olympiques de Paris durant l'été 2024. Il y exerçait la fonction de délégué technique avec des amplitudes horaires particulièrement importantes, de 7h à 22h heures, sur toute la durée de l'événement. C'est à cette occasion qu'il rapporte avoir pris conscience de manière aiguë de la charge de travail et du niveau d'exigence liés à son activité. Il situe également à cette période l'apparition des premiers envahissements anxieux et le sentiment d'être dépassé par les contraintes professionnelles.

Aspects familiaux et sentimentaux : L'assuré est marié depuis juillet 2021. Son épouse exerce également dans le domaine du tir à l'arc en tant qu'entraîneur à Lausanne. Le couple n'a pas d'enfant et la relation est décrite comme stable et soutenante. Son épouse est présentée comme comprenant les contraintes liées à son activité professionnelle et au rythme de vie qui en découle, d'autant plus qu'ils évoluent tous deux dans le même environnement sportif et partagent la même passion.

Aspects scolaires et professionnels : L'assuré décrit une scolarité déroulée en région parisienne pour l'école maternelle et primaire, puis le collège et le lycée sans difficulté particulière. Il ne rapporte ni trouble des apprentissages, ni problème de socialisation, et décrit un parcours scolaire globalement régulier. Il obtient un baccalauréat en filière économique et sociale, puis s'oriente vers un brevet de technicien supérieur en commerce international débuté à l'âge de dix-neuf ans. Il poursuit ensuite ses études à l'École supérieure de commerce et de management de Tours, avec une spécialisation en "*Supply Chain Management et Achats*".

Sur le plan professionnel, il a effectué l'ensemble de sa carrière dans le domaine de l'organisation d'événements sportifs au sein de la fédération internationale de tir à l'arc. Il y débute comme stagiaire coordinateur du développement, puis occupe progressivement des fonctions à responsabilité croissante. Il accède ensuite à un poste d'assistant du secrétaire général. Depuis août 2019, il exerce la fonction de responsable des événements et du marketing (Head of Events).

and Marketing) au sein de la structure basée à Lausanne, avec un rôle central dans la planification, la coordination et la stratégie des manifestations sportives internationales.

Description du dernier poste de travail : L'assuré occupe depuis août 2019 le poste de Head of Events and Marketing au sein de la Fédération internationale de tir à l'arc, basée à Lausanne, avec un taux contractuel d'activité de 100 %. Dans le domaine des événements, il est chargé de la gestion globale des compétitions internationales. Son activité comprend le suivi des procédures de candidature des villes organisatrices, la réalisation de visites d'inspection, l'élaboration de stratégies et de rapports destinés aux instances exécutives, ainsi que la coordination de l'ensemble de l'équipe événementielle. Il supervise les prestataires et contractants impliqués dans les manifestations, participe à la planification logistique, contribue à l'élaboration du calendrier international en collaboration avec le secrétariat général et veille à l'application des règles d'accréditation. Il intervient également dans la préparation des cérémonies protocolaires et dans la formation des équipes opérationnelles.

Sur le versant marketing, il est responsable du développement du programme de marketing et de parrainage. Il assure la gestion du *merchandising*, le contrôle des droits d'auteur et la protection de la propriété intellectuelle de la fédération. Il supervise les services marketing, veille à l'application des directives en matière d'image et de marque par les comités d'organisation locaux et assume la responsabilité budgétaire pour l'ensemble des contractants relevant de son secteur.

Perception de son avenir professionnel avec les limitations fonctionnelles perçues par l'expertisé : L'assuré décrit son activité professionnelle comme un "*métier passion*". Il souligne la qualité du travail accompli ainsi que de ses compétences dans l'organisation et la gestion d'événements sportifs internationaux. À ce titre, il ne remet pas en cause ses capacités professionnelles intrinsèques. Cependant, la projection dans l'avenir professionnel reste actuellement floue. Cette incertitude n'est pas liée à un sentiment d'incompétence, mais une appréhension vis-à-vis de la nouvelle direction de la fédération et au climat de travail qu'il anticipe comme potentiellement délétère.

Perception de la situation financière : L'assuré décrit sa situation financière comme globalement stable et ne se sent pas en danger sur ce plan.

Activités sociales et/ou bénévoles : Il ne rapporte actuellement aucune activité associative ou bénévole.

Service militaire, intérêt pour les armes : L'assuré n'a pas effectué de service militaire. Son intérêt pour les armes se limite strictement à la pratique du tir à l'arc dans un cadre sportif et sécurisé, sans attrait particulier pour les armes à feu.

Déroulement détaillé et représentatif d'une journée type, organisation des loisirs, hobbies, aides nécessaires pour le ménage et dans la vie quotidienne, moyens de transport utilisés, types de déplacements, vacances, etc.

Depuis le début de l'arrêt de travail, la journée type de l'assuré est marquée par un ralentissement important dans le quotidien et une perte d'élan vital. Il se lève vers 9h30, prend quelques tasses de café et tente de réaliser quelques démarches administratives simples ou de consulter ses courriels, conformément aux recommandations de son psychologue. Ces activités entraînent rapidement une fatigabilité marquée. Il ne prépare plus le repas de midi, activité auparavant investie, et se contente le plus souvent de solutions simples en raison de l'épuisement et des difficultés de concentration. L'après-midi est essentiellement consacrée à des activités passives telles que regarder la télévision, ce qu'il décrit lui-même comme inhabituel au regard de son fonctionnement antérieur très actif. Il ne pratique plus de sport et ne parvient plus à maintenir d'activités intellectuelles soutenues. Il s'efforce toutefois de préparer le repas du soir pour son épouse, geste qu'il associe à un sentiment de reconnaissance. Les tâches ménagères sont

partagées avec son épouse, mais leur réalisation reste difficile. Le coucher survient tardivement, entre une heure et deux heures du matin, en raison de difficultés d'endormissement liées aux ruminations. Le sommeil est non réparateur. Il rapporte une fatigabilité majeure, une perte pondérale d'environ huit kilogrammes, une diminution très nette du périmètre de marche et une lenteur importante dans l'exécution des tâches du quotidien. Les déplacements sont limités au strict nécessaire, principalement aux rendez-vous médicaux et à de courtes sorties pour des courses domestiques. Les moyens de transport utilisés sont la voiture et les transports publics. Il ne pratique actuellement aucun loisir ni hobby. Concernant les vacances, le dernier séjour remonte à décembre 2024 au Mexique pour rendre visite à la famille de son épouse. Depuis cette date, ce voyage annuel habituel n'a pas pu être reconduit, ce qui constitue un élément vécu comme pesant, tant pour lui que pour sa conjointe.

Anamnèse psychiatrique systématique

Fonctions cognitives : L'assuré décrit avant tout un trouble majeur de la concentration, avec une attention fluctuante et difficile à maintenir dans la durée. Cette difficulté est vécue comme particulièrement déstabilisante compte tenu de son identité d'archer de haut niveau, discipline dans laquelle les capacités attentionnelles sont habituellement très développées. Il rapporte une mémoire autobiographique et de long terme conservées, mais avec des difficultés marquées de mémoire de travail, avec une sensation d'être rapidement débordé lorsqu'il doit intégrer de nouvelles informations ou gérer plusieurs éléments simultanément.

Humeur : L'assuré évalue son humeur comme globalement neutre mais instable lors de l'examen. Il ne rapporte plus d'idées de mort, ni passives ni actives. Les éléments prédominants sont une anhédonie importante, une perte d'élan vital et un sentiment de culpabilité, en particulier vis-à-vis de son épouse, ainsi qu'une diminution de l'estime de soi. Il décrit également une irritabilité accrue par rapport à son fonctionnement habituel.

Angoisse et dissociation : L'assuré indique que les envahissements anxieux se sont nettement atténués depuis la mi-janvier. Persistent néanmoins des ruminations importantes centrées sur l'avenir professionnel, la perspective de reprise du travail et la remise en question de ses propres limites, notamment le fait de ne pas avoir demandé de l'aide plus précocement. Il ne rapporte pas de phénomènes dissociatifs actuels.

Fonctions « végétatives » et autres symptômes d'allure somatoforme : Les fonctions végétatives sont altérées avec une perte pondérale d'environ 12 kg depuis le mois de septembre, une diminution de l'appétit et des troubles du sommeil marqués par des difficultés d'endormissement, un sommeil fragmenté, non réparateur, associé à des cauchemars.

Utilisation de substances, dépendances : L'assuré rapporte une augmentation transitoire de la consommation d'alcool dans la période précédant l'arrêt de travail, décrite comme un mode de gestion de la tension lors de la phase de surcharge maximale. En dehors de cet épisode, la consommation était occasionnelle et modérée. Il n'existe pas de consommation actuelle d'alcool et il n'a jamais consommé de substances stupéfiantes.

Conflit avec la réalité : L'assuré ne décrit pas d'idées délirantes, ni d'hallucinations, ni de sentiment actuel de déréalisation ou de dépersonnalisation.

Personnalité : L'assuré se décrit comme peu porté vers une vie sociale étendue, avec un tempérament direct, peu filtré, volontiers sanguin, associé à un fort perfectionnisme et à un besoin marqué de bien faire. Ces traits s'inscrivent dans un fonctionnement antérieur de haut niveau d'investissement et d'exigence personnelle.

Antécédents familiaux psychiatriques :

Aucun selon l'assuré.

Antécédents personnels psychiatriques :

Aucun antécédent psychiatrique antérieur à l'épisode actuel. Il n'avait jamais bénéficié de suivi spécialisé, n'avait jamais reçu de traitement psychotrope et n'a jamais été hospitalisé en psychiatrie. Il ne rapporte pas non plus d'antécédent de tentative de suicide. Il précise par ailleurs ne pas avoir consulté de médecin généraliste en Suisse avant l'apparition des troubles.

Traitement(s) suivi(s) à ce jour y compris médicamenteux (en indiquant aussi les méthodes thérapeutiques ne relevant pas de la médecine traditionnelle ou l'absence éventuelle de traitement).

Le traitement antidépresseur par Sertraline a été instauré le 6 octobre 2025 par son médecin généraliste, Le Dr Sampieru Felli, à la posologie initiale de 50 mg par jour. Cette posologie a été augmentée à 100 mg le 28 octobre 2025, puis maintenue jusqu'au 29 janvier 2026. À cette date, lors de la première consultation spécialisée en psychiatrie, avec le Dr William Caredda, la Sertraline a été majorée à 150 mg par jour et un traitement adjuvant par Melioran à raison d'un comprimé par jour a été introduit.

Parallèlement au traitement médicamenteux, l'assuré bénéficie d'un suivi psychothérapeutique régulier, depuis le 28 août 2025, auprès de M. Jonathan Matile, psychologue FSP à Pully. D'après le courrier de ce dernier, en date du 06 octobre 2025, le travail thérapeutique est actuellement centré sur la stabilisation thymique, la restauration du sommeil et le renforcement des ressources psychiques. Les axes principaux concernent la gestion du stress, la régulation émotionnelle et la prévention des schémas perfectionnistes. Des recommandations comportementales ont également été formulées, visant à maintenir des contacts sociaux pour prévenir l'isolement, à instaurer une activité physique douce et régulière, à sortir quotidiennement, à structurer les journées selon des horaires stables et à réintroduire des activités agréables.

Perception de l'avenir, en général et en lien avec une activité professionnelle ou avec la réadaptation professionnelle

Sur le plan général, l'assuré conserve une vision globalement positive de son avenir. Il se montre conscient de la solidité de son parcours et de ses compétences, ce qui constitue un facteur de protection. Toutefois, en lien avec la sphère professionnelle, la projection reste floue. Sa priorité actuelle est clairement orientée vers l'amélioration de son état psychique et la récupération de ses capacités fonctionnelles. Il ne se projette pas, à ce stade, dans une reprise précoce du travail ni dans un processus de réadaptation professionnelle, estimant que ces questions ne pourront être abordées de manière pertinente qu'une fois un rétablissement psychique suffisant obtenu.

Médecins actuels :

- Dr Sampieru Felli, Médecin généraliste, Maison de Santé Pully, à Pully
- M. Jonathan Matile, Psychologue FSP, à Pully
- Dr William Caredda, Psychiatre et Psychothérapeute, à Lausanne

QUESTIONNAIRE DE L'ASSURANCE

1. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ?

L'assuré ne rapporte pas d'antécédent médical ou psychiatrique significatif avant l'épisode actuel et décrit un fonctionnement antérieur caractérisé par un niveau d'investissement professionnel très élevé. Il indique avoir longtemps dépassé ses limites sans en percevoir les effets, considérant ce mode de fonctionnement comme habituel pour lui. La symptomatologie actuelle s'inscrit dans une évolution progressive débutant à l'été 2024, dans le contexte d'une surcharge professionnelle majeure lors des Jeux olympiques de Paris, avec une aggravation nette en décembre 2024 sur

fond de tensions organisationnelles et de vécu de manque de soutien hiérarchique, d'après ses dires. Se sont alors installés une fatigue psychique persistante, une tension interne quasi permanente, une irritabilité inhabituelle et une anxiété de fond avec ruminations centrées sur le travail. Le sommeil s'est progressivement désorganisé, avec des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes en lien avec les préoccupations professionnelles, ainsi qu'une diminution de l'appétit et une perte pondérale.

Monsieur décrit un épisode de sidération lors d'un déplacement à l'étranger, marqué par une incapacité transitoire à initier des actions simples, ainsi que des manifestations d'envahissement anxieux, des comportements d'évitement et des troubles attentionnels. Dans ce contexte d'épuisement, il rapporte la survenue d'une pensée de mort lors d'un accident de vélo sans gravité. Malgré ces difficultés, il a poursuivi son activité professionnelle avec des déplacements internationaux répétés jusqu'à un état d'épuisement avancé, période au cours de laquelle la consommation d'alcool a augmenté de manière inhabituelle, vécue par l'assuré comme un point de rupture. Le dossier médical atteste d'une incapacité de travail totale et continue depuis le 15 septembre 2025. L'évaluation psychologique met en évidence un épisode dépressif d'intensité moyenne à sévère dans un contexte de burnout professionnel, avec des scores pathologiques aux échelles de dépression et d'épuisement. Le médecin traitant décrit une surcharge cognitive et émotionnelle, des troubles de la concentration, une irritabilité et une majoration transitoire de la consommation d'alcool.

Un traitement antidépresseur par Sertraline a été instauré puis progressivement augmenté dans le cadre du suivi psychiatrique. Depuis l'introduction du traitement et la mise en place du suivi psychothérapeutique, l'assuré décrit une stabilisation de l'état thymique sans aggravation, mais sans récupération significative de son niveau de fonctionnement antérieur.

2. QUELLES SONT LES PLAINTES ACTUELLES ?

L'assuré évoque une perte de ses capacités de concentration avec une attention fluctuante et une fatigabilité cognitive rapide, associé à des difficultés de mémoire de travail et à un sentiment d'être rapidement débordé lors de la gestion d'informations nouvelles ou multiples. Sur le plan thymique, il décrit une humeur globalement neutre mais instable, dominée par une anhédonie, une perte d'élan vital, une baisse de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité notamment vis-à-vis de son épouse et une irritabilité accrue. Les envahissements anxieux se sont atténués depuis quelques semaines, mais persistent des ruminations importantes centrées sur l'avenir professionnel, la reprise du travail et la remise en question de ses propres limites. Les fonctions végétatives sont altérées avec une perte pondérale évoquée d'environ 12 kg, une diminution de l'appétit et des troubles du sommeil marqués par des difficultés d'endormissement, un sommeil fragmenté, non réparateur et des cauchemars. Il n'existe plus de consommation actuelle d'alcool, celle-ci ayant été transitoirement augmentée avant l'arrêt de travail dans un contexte de surcharge, et il n'y a pas de consommation de substances selon ses dires. L'assuré ne présente pas de symptômes psychotiques ni de phénomène dissociatif.

3. QUELLES CONSTATATIONS PSYCHOPATHOLOGIQUES, Y COMPRIS LES RÉSULTATS D'ÉVENTUELS EXAMENS COMPLÉMENTAIRES (LABORATOIRE/MÉDICAMENTS), POUVEZ-VOUS FOURNIR ?

Constatations objectives

Observations relatives au comportement et à l'apparence extérieure

L'assuré se présente seul à l'entretien, vêtu de manière adaptée à la saison, sans signe d'incurie ni de négligence. Le contact visuel est bon, avec une posture d'emblée cordiale et une attitude collaborative et ouverte tout au long de l'entretien, sans familiarité. On note toutefois une tonalité anxieuse avec des mouvements de rapprochement répétés vers le bureau et une certaine instabilité motrice lors des moments de participation affective intense. Il n'est pas observé de ralentissement psychomoteur franc.

Compréhension linguistique

Le français est sa langue maternelle, avec une expression fluide, un vocabulaire riche et des réponses adaptées aux questions posées.

Status psychiatrique

Fonctions cognitives : L'assuré est correctement orienté dans le temps et dans l'espace, avec une vigilance préservée. La mémoire autobiographique et chronologique apparaît intacte. Le discours est globalement cohérent et informatif, mais marqué par une diffluence et une tendance à une accélération du rythme par moments, en lien avec une anxiété sous-jacente et des capacités attentionnelles diminuées. La concentration apparaît fluctuante au cours de l'entretien, avec une fatigabilité palpable en fin d'entretien.

Humeur : L'humeur observée est marquée par une participation affective importante lors de l'évocation des difficultés professionnelles. La mimique est mobile et adaptée au contenu du discours. Le ton de la voix devient par moments tremblant, avec une charge émotionnelle perceptible. Le discours contient des éléments à tonalité dépressive tels qu'un sentiment de culpabilité et une faible estime de soi. Il n'y a pas d'élément en faveur d'un syndrome mélancolique, ni de signes d'allure hypomaniaque ou maniaque. Aucune idée suicidaire n'est exprimée au moment de l'examen.

Anxiété et dissociation : L'anxiété est au premier plan de l'observation clinique, perceptible dès le début de l'entretien. Elle se manifeste par une hyperverbosité par moments, des tremblements discrets et une instabilité posturale. Il n'est pas observé de symptomatologie compatible avec des attaques de panique ou des phénomènes dissociatifs.

Utilisation de substances : Il n'existe pas d'élément objectif en faveur d'une intoxication aiguë ou consommation récente de substances.

Conflit avec la réalité : Le contact avec la réalité est conservé, sans idées délirantes ni troubles perceptifs mis en évidence.

Personnalité : Le fonctionnement apparaît marqué par un haut niveau d'exigence personnelle, un investissement important dans les tâches et une tendance au perfectionnisme, avec un mode relationnel direct et peu filtré. Il n'est pas mis en évidence de traits d'impulsivité pathologique, d'instabilité relationnelle ou professionnelle. Nous ne retrouvons pas d'élément en faveur d'un trouble de la personnalité constitué.

Constatations complémentaires

Évaluation de l'addiction selon la classification de DSM-5 :

Non nécessaire.

Examens exigeant un appareillage ou des analyses de laboratoire

Un dosage sérique de la Sertraline a été réalisé le 10 février 2026. Le taux mesuré à 113 ng/ml se situe dans les valeurs thérapeutiques attendues au regard de la posologie prescrite et ne suggère ni sous-dosage ni surdosage cliniquement significatif. Le bilan biologique standard comprenant une formule sanguine, un bilan hépatique et un bilan rénal est dans les limites de la norme. La TSH est également dans les valeurs usuelles, sans argument en faveur d'une dysthyroïdie. La recherche de toxiques urinaires s'est révélée négative. Il n'existe pas d'élément biologique en faveur d'une consommation de substances psychoactives ni d'une consommation chronique d'alcool. L'ensemble des examens complémentaires ne met pas en évidence d'anomalie somatique susceptible d'expliquer ou d'entretenir la symptomatologie psychiatrique actuelle.

Tests psychologiques complémentaires

Non nécessaire.

Informations éventuelles fournies par des tiers (y c. médecins traitants)

Non nécessaire.

4. QUELS SONT LES MÉDICAMENTS PRIS / LES THÉRAPIES EFFECTUÉES (DOSAGE, QUANTITÉ, FRÉQUENCE) ?

L'assuré bénéficie actuellement d'un traitement antidépresseur par Sertraline à la posologie de 150 mg par jour en prise unique quotidienne. Ce traitement a été introduit le 6 octobre 2025 à 50 mg par jour par le médecin généraliste, puis augmenté à 100 mg par jour à partir du 28 octobre 2025. Lors de la première consultation psychiatrique le 29 janvier 2026, la posologie a été majorée à 150 mg par jour. Un traitement adjuvant par Melioran (phytothérapie) a été instauré à la même date, à raison d'un comprimé par jour. Sur le plan psychothérapeutique, l'assuré est suivi de manière régulière, à raison d'entretiens individuels dont la fréquence est hebdomadaire. Le travail thérapeutique est centré sur la stabilisation de l'humeur, la restauration du sommeil et le renforcement des ressources psychiques. Il comprend également une prise en charge orientée vers la gestion du stress, la régulation émotionnelle, l'identification et la modification des schémas perfectionnistes ainsi que la prévention de l'épuisement.

5. QUEL(S) EST / SONT LE/S DIAGNOSTIC(S) AYANT UNE INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL (VEUILLEZ INDIQUER LE CODE CIM) ?

Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.01)

Anxiété généralisée (F41.1)

6. QUEL(S) EST / SONT LE/S DIAGNOSTIC(S) N'AYANT PAS D'INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL (VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE CIM)?

Nihil.

7. QUEL EST LE TAUX D'ACTIVITÉ ESTIMÉ (EN POURCENTAGE) DANS L'EMPLOI ACTUEL, Y COMPRIS LES RAISONS ET LE PRONOSTIC ?

Dans l'emploi actuel, le taux d'activité est estimé à 0 % à ce jour. Cette incapacité totale est en lien avec l'état psychique encore instable, la persistance de troubles cognitifs significatifs, notamment attentionnels et exécutifs, la fatigabilité importante, ainsi que les ruminations envahissantes centrées sur la sphère professionnelle. À cela s'ajoute le contexte d'adaptation thérapeutique récent avec l'augmentation de la Sertraline à 150 mg/j, qui nécessite un délai d'évaluation suffisant pour apprécier pleinement l'efficacité clinique et la tolérance. L'ensemble de ces éléments est actuellement incompatible avec les exigences de la fonction exercée, caractérisée par une charge mentale élevée, une gestion multitâche, des responsabilités décisionnelles importantes et des déplacements internationaux fréquents. Le pronostic est favorable à moyen terme sous réserve de la poursuite du traitement et de la prise en charge psychothérapeutique. Une reprise de l'activité ne peut être envisagée que de manière très progressive et structurée, compte tenu du risque important de rechute. Une réévaluation de la capacité de travail est recommandée à un horizon d'environ 16 (seize) semaines à compter de la date de l'expertise, afin d'apprécier l'évolution clinique sous traitement stabilisé et d'envisager, le cas échéant, une montée en charge graduelle du taux d'activité.

8. QUEL EST LE TAUX D'ACTIVITÉ ESTIMÉ (EN POURCENTAGE) DANS UN EMPLOI ADAPTÉ, Y COMPRIS LES RAISONS ET LE PRONOSTIC ?

À ce jour, le taux d'activité dans un emploi adapté est également estimé à 0 %. Cette estimation repose sur les mêmes éléments cliniques que pour l'emploi habituel, à savoir la persistance de troubles cognitifs marqués, en particulier attentionnels et exécutifs, une fatigabilité importante, des ruminations envahissantes, ainsi qu'un état thymique encore fragile. La majoration récente du traitement antidépresseur à 150 mg/j ne permet pas encore d'évaluer de manière fiable l'effet thérapeutique optimal et un **délai de huit semaines** est nécessaire pour apprécier la réponse clinique après adaptation posologique. Le pronostic peut être considéré comme favorable sous réserve d'une stabilisation de l'état psychique sous traitement et de la poursuite du suivi psychothérapeutique. Une reprise progressive dans une activité adaptée pourrait être envisagée, après cette période d'observation, à condition que le cadre professionnel respecte des aménagements stricts visant à limiter le risque de rechute. Ces aménagements devraient comprendre une activité centrée sur l'absence de multitâche, l'absence de pression temporelle et de contraintes décisionnelles importantes, une réduction des exigences hiérarchiques, la suppression des déplacements professionnels et la possibilité de travailler majoritairement à domicile dans un premier temps. Ce type d'adaptation apparaît d'autant plus pertinent que l'assuré exprime le souhait de reprendre son activité au sein de son poste actuel, ce qui implique d'envisager prioritairement des mesures d'aménagement plutôt qu'une réorientation professionnelle immédiate.

9. EST-CE QU'UNE ADAPTATION DU TRAITEMENT/DE LA THÉRAPIE, POURRAIT AVOIR UN EFFET BÉNÉFIQUE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL (PARTIELLE). SI OUI, LE(S)QUEL(S), POUR QUELLES RAISONS ET QUEL SERAIT LE PRONOSTIC ?

Une adaptation récente du traitement pharmacologique a déjà été effectuée avec la majoration de la Sertraline à 150 mg par jour lors de la prise en charge spécialisée en psychiatrie. Dans ce contexte, proposer à ce stade une nouvelle modification médicamenteuse serait prématuré et

redondant, l'effet clinique de cette adaptation nécessitant encore un délai d'évaluation suffisant. La prise en charge actuelle apparaît conforme aux recommandations, associant un traitement antidépresseur à posologie thérapeutique, un suivi psychothérapeutique structuré ainsi qu'un accompagnement régulier par le médecin généraliste et le psychiatre. La poursuite de ce dispositif thérapeutique, sans modification immédiate, est susceptible d'avoir un effet bénéfique progressif sur la symptomatologie, en particulier sur la stabilisation thymique, la réduction des ruminations, l'amélioration des capacités attentionnelles et la diminution de la fatigabilité.

10. REMARQUES

Toutes les remarques utiles ont été faites.